

PUBMED DAILY WATCH • 2026-06-13

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文献 监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-06-07 至 2026-06-13。每篇文章单独 1 页 slide，并明确区分已验证证据、论文作者观点和我的推断；本页只做文献监测和研究设计启示，不提供医疗建议。

EDAT 新入库

46

PDAT 发表日期

30

MDAT 记录更新

287

精选文献

5

下载 PDF

下载 PPTX

固定公网链接

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch 于 2026-06-13 检索；窗口为 2026-06-07 至 2026-06-13，合并 EDAT、PDAT、MDAT 覆盖近 7 天新增、发表和记录更新。官方计数为 EDAT 46、PDAT 30、MDAT 287，去重候选池 293 条。本日沿用 5 papers/day 和 pubmed-history.json 去重，选择 5 篇未跨日重复 PMID；今日新增高相关临床/转化信号集中在 CAR-T、双抗+ADC、双抗免疫监测和 CAR-T 神经毒性管理，CNSL/PCNSL 方向补入 1 篇 MDAT 更新的机制治疗研究，并已明确标注其不是本周新发表临床研究。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

#	方向	疾病	PMID	标题
1	CAR-T / 免疫检查点工程 / R/R LBCL	复发/难治 large B-cell lymphoma	42284198	Anbal-cel: PD-1/TIGIT 双敲低 CD19 CAR-T 在 R/R LBCL 的 I/II 期研究
2	双抗 + ADC / CD20xCD3 / R/R LBCL	复发/难治 large B-cell lymphoma	42283231	Mosun-Pola vs R-Pola: 皮下 mosunetuzumab 联合 polatuzumab 的随机 II 期 LBCL 数据
3	双抗 / epcoritamab / 真实世界免疫监测	R/R LBCL 与滤泡性淋巴瘤；包含疑似 CNS 复发个案	42278654	Epcoritamab 真实世界小队列: R/R LBCL/FL 的疗效、TCRVβ 重塑与疑似 CNS 复发信号
4	CAR-T 安全性 / ICANS / anakinra	侵袭性 B 细胞淋巴瘤，包括 DLBCL	42279369	CAR-T 后预防性 anakinra: 单中心真实世界数据显示未降低 ICANS 发生率
5	CNSL / PCNSL / 靶向联合与 PANoptosis 机制	primary central nervous system lymphoma	41720446	PCNSL 机制治疗更新: KPT-8602 + IFN-γ 激活 ZBP1-PANoptosome 抑制肿瘤进展

Anbal-cel: PD-1/TIGIT 双敲低 CD19 CAR-T 在 R/R LBCL 的 I/II 期研究

Anbaltagene autoleucel (PD-1 and TIGIT knockdown CD19 CAR-T) for relapsed/refractory large B-cell lymphoma (CRC01-01).

PMID 42284198

打开 PubMed

CAR-T / 免疫检查点工程 / R/R LBCL

复发/难治 large B-cell lymphoma

EDAT/PDAT/MDAT 命中: 2026-06-12 进入 PubMed, 本轮近 7 天新增/更新

人群

复发/难治 large B-cell lymphoma 患者

干预/暴露

Anbaltagene autoleucel, PD-1/TIGIT 双敲低 CD19 CAR-T

比较

单臂 I/II 期研究; 主要与历史 CD19 CAR-T 经验形成背景比较

结局

CR/PR、PFS、OS、CAR-T 扩增、PD-1/TIGIT 表达、CRS、神经事件和感染

结论

Anbaltagene autoleucel 是一种 CD19 CAR-T, 同时敲低 PD-1 和 TIGIT, 以增强抗肿瘤功能和持久性。II 期 79 例给药、73 例可评价疗效中, CR 率 67.1%、PR 率 8.2%, 中位 PFS 6.04 个月, 12 个月 PFS 41.1%; 12 和 18 个月 OS 率分别为 66.6% 和 57.3%。长期反应者的 CAR 阳性 T 细胞 PD-1/TIGIT 表达更低, 提示工程化免疫检查点调控可能与持久缓解相关, 但 3 级及以上不良事件很常见, 感染风险需要重点关注。

主要内容

- 研究为 CRC01-01 I/II 期, 目标人群是 R/R LBCL; II 期 79 例接受 Anbal-cel, 其中 73 例纳入疗效评价。
- 疗效信号: CR 67.1%、PR 8.2%; 中位 PFS 6.04 个月, 6/12/18 个月 PFS 率为 50.9%、41.1%、35.2%; 中位 OS 未达到。
- 药效学信号: 响应者 CAR-T 扩增显著更高; 按 6 个月持续 CR 定义长期反应后, 长期反应组 CAR 阳性 T 细胞 PD-1 和 TIGIT 表达降低。
- 安全性: 97.5% 出现 3 级及以上 AE; CRS 57.0%、神经事件 13.9%; 3 级 CRS 8.9%, 3 级及以上神经事件 3.8%; 严重感染 25.3%, 3 例 5 级感染。

关键信息

- 作者: Won Seog Kim、Seok Jin Kim、Dok Hyun Yoon、Hyungwoo Cho、Sang Eun Yoon、Deok Hwan Yang 等。
- 核心设计: CD19 CAR-T + PD-1/TIGIT 双敲低, 试图把检查点耗竭控制直接写入细胞产品。
- 核心数据: CR 67.1%; 中位 PFS 6.04 月; CAR-T Cmax 在响应者中更高; 长期反应组 PD-1/TIGIT 表达更低。
- 方向标签: CD19 CAR-T、PD-1、TIGIT、R/R LBCL、长期反应、感染安全性。

启示

已验证证据

已验证证据: PubMed 摘要明确报告 Anbal-cel 在 R/R LBCL 中的 CR/PR、PFS/OS、CAR-T 扩增、PD-1/TIGIT 表达和 CRS/神经毒性/感染数据。

论文作者观点

论文作者观点: 双 PD-1/TIGIT knockdown CD19 CAR-T 可增强抗肿瘤功能和持久性, 长期反应者的检查点表达降低支持该工程化策略的生物学合理性。

我的推断

我的推断: 后续 CAR-T 研究可以把“产品内建免疫检查点调控”作为与传统 CD19 CAR-T 区分的关键变量, 同时必须把严重感染作为疗效之外的并行风险终点; 当前结果不能直接外推为优于既有 CAR-T 的治疗推荐。

Mosun-Pola vs R-Pola：皮下 mosunetuzumab 联合 polatuzumab 的随机 II 期 LBCL 数据

PMID 42283231

打开 PubMed

A Randomized Phase II Study of Subcutaneous Mosunetuzumab in Combination With Polatuzumab Vedotin Compared With Rituximab Plus Polatuzumab Vedotin in Patients With Relapsed or Refractory Large B-Cell Lymphoma.

双抗 + ADC / CD20xCD3 / R/R LBCL

复发/难治 large B-cell lymphoma

EDAT/PDAT/MDAT 命中: 2026-06-12 进入 PubMed, 本轮近 7 天新增/更新

P 人群

至少 1 线既往治疗后的 R/R LBCL 患者

I 干预/暴露

皮下 mosunetuzumab + polatuzumab vedotin

C 比较

rituximab + polatuzumab vedotin

O 结局

ORR、CR、PFS、OS、CRS 和固定疗程可行性

结论

这项随机 II 期队列比较皮下 mosunetuzumab + polatuzumab vedotin (Mosun-Pola) 与 rituximab + polatuzumab (R-Pola)。80 例 R/R LBCL 中, Mosun-Pola 的最佳 ORR 为 77.5%, R-Pola 为 50.0%; CR 率为 55.0% vs 35.0%; 中位 PFS 为 25.4 vs 6.4 个月, HR 0.47。CRS 在 Mosun-Pola 组为 12.5%, 均为 1/2 级。该研究把双抗和 ADC 的固定疗程联合作为 R/R LBCL 可及治疗路径的重要证据点。

主要内容

- 入组 R/R LBCL 且至少 1 线既往治疗; Mosun-Pola 40 例, R-Pola 40 例; 随访超过 2 年。
- 给药: mosunetuzumab 皮下 C1 step-up 后至 C8; polatuzumab vedotin C1-6; 对照组 rituximab C1-8 + polatuzumab C1-6。
- 疗效: 最佳 ORR 77.5% vs 50.0%; CR 55.0% vs 35.0%; 中位 PFS 25.4 vs 6.4 月; 中位 OS 未达到 vs 25.5 月。
- 安全性摘要: Mosun-Pola 组 CRS 12.5%, 均为 1/2 级; 摘要称固定疗程 Mosun-Pola 在所有疗效终点均优于 R-Pola。

关键信息

- 作者: Julio C Chavez、Mariana Bastos-Oreiro、Catherine Diefenbach、Izidore S Lossos、Nirav Shah、Sarit Assouline 等。
- 核心组合: CD20xCD3 双抗 mosunetuzumab + CD79b ADC polatuzumab vedotin。
- 核心数据: ORR 77.5% vs 50.0%; CR 55.0% vs 35.0%; PFS 25.4 vs 6.4 月, HR 0.47。
- 方向标签: mosunetuzumab、polatuzumab vedotin、bispecific antibody、ADC、fixed-duration、R/R LBCL。

启示

已验证证据

已验证证据: PubMed 摘要明确报告随机 II 期 Mosun-Pola 相比 R-Pola 的 ORR、CR、PFS 和 CRS 数据。

论文作者观点

论文作者观点: 固定疗程 Mosun-Pola 在 R/R LBCL 中较 R-Pola 显示跨疗效终点获益, 并与全球 III 期 SUNMO 研究观察到的获益方向一致。

我的推断

我的推断: 这一结果值得在“CAR-T 不可及、等待期桥接、或需要即用型免疫方案”的研究框架中重点跟踪; 但样本量为 80 例, 且比较对象是 R-Pola, 不应写成对所有二线/三线策略的直接替代结论。

Epcoritamab 真实世界小队列：R/R LBCL/FL 的疗效、TCR Vβ 重塑与疑似 CNS 复发信号

Clinical Outcomes and Exploratory Longitudinal CTL/Vβ Repertoire Remodeling in Patients with Relapsed or Refractory Large B-Cell Lymphoma and Follicular Lymphoma Treated with Epcoritamab.

PMID 42278654

打开 PubMed

双抗 / epcoritamab / 真实世界免疫监测

R/R LBCL 与滤泡性淋巴瘤；包含疑似 CNS 复发个案

EDAT/MDAT 命中：2026-06-12 进入 PubMed，本轮近 7 天新增/更新

P 人群

接受 epcoritamab 的 R/R LBCL 和 R/R FL 连续病例

I 干预/暴露

皮下 CD3xCD20 双抗 epcoritamab

C 比较

描述性真实世界队列；停药 CR 病例进行免疫模式观察

O 结局

ORR、OS、疑似 CNS 复发影像学反应、CTL 亚群和 TCR Vβ repertoire 变化

结论

这项单机构回顾性研究纳入 21 例接受 epcoritamab 的 R/R B 细胞淋巴瘤患者，其中 17 例为 R/R LBCL。可评价患者中，LBCL ORR 为 9/14，FL 为 4/4；1 例临床和影像学疑似 CNS 复发的 LBCL 患者在 epcoritamab 后达到影像学完全缓解。部分完全缓解后选择停药病例出现 Vβ 偏倚 CTL 群体和记忆 CTL 高于效应 CTL 的模式，提示双抗持久缓解可能与 T 细胞克隆/亚群重塑有关，但仍为探索性发现。

主要内容

- 研究时间覆盖 2023-12-01 至 2025-12-31 启动 epcoritamab 的连续病例，随访更新至 2026-05-18。
- 队列包括 17 例 R/R LBCL 和 4 例 R/R FL；进行临床结局、CTL 亚群和 TCR Vβ repertoire 的纵向探索分析。
- 疗效：可评价 LBCL 患者 ORR 9/14，FL 4/4；LBCL 和 FL 中位 OS 分别约 431 天和 431.5 天。
- 转化信号：疑似 CNS 复发 LBCL 患者影像学 CR；完全缓解后选择停药病例可见 Vβ-skewed CTL 与记忆 CTL 优势。

关键信息

- 作者：Tatsuro Jo、Jun Taguchi、Yasushi Sawayama、Masatoshi Matsuo、Kaho Umemoto、Kaori Yamaguchi 等。
- 核心价值：把 epcoritamab 疗效、停药后持续缓解和 T 细胞 repertoire 重塑放在同一观察框架中。
- CNS 相关：摘要提到 1 例疑似 CNS 复发 LBCL 在 epcoritamab 后影像学完全缓解，但这是个案信号。
- 方向标签：epcoritamab、CD3xCD20、CTL subset、TCR Vβ repertoire、CNS involvement、durable remission。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要报告 21 例 epcoritamab 治疗患者、LBCL ORR 9/14、疑似 CNS 复发个案影像学 CR，以及部分停药 CR 病例中的 CTL/Vβ 重塑观察。

论文作者观点

论文作者观点：epcoritamab 可能与部分响应者的 CTL 亚群和 Vβ 偏倚群体纵向重塑相关，这些免疫模式与持久缓解和停药的潜在关系需要更大前瞻队列验证。

我的推断

我的推断：双抗研究不应只记录 ORR/CR，还应同步设计 T 细胞 repertoire、记忆/效应 CTL 比例和停药后免疫监测；CNS 个案只能作为假设生成，不能推断 epcoritamab 已被证实可治疗 CNS 复发。

CAR-T 后预防性 anakinra：单中心真实世界数据显示未降低 ICANS 发生率

Prophylactic Anakinra to Prevent Neurotoxicity After CAR T-Cell Therapy in Aggressive B-Cell Lymphomas: A Single-Center Real-World Experience.

PMID 42279369

打开 PubMed

CAR-T 安全性 / ICANS / anakinra

侵袭性 B 细胞淋巴瘤，包括 DLBCL

EDAT/MDAT 命中：2026-06-12 进入 PubMed，本轮近 7 天新增/更新

人群

接受 CD19 CAR-T 的侵袭性 B 细胞淋巴瘤患者

干预/暴露

预防性 anakinra day 0 至 +6

比较

未使用预防性 anakinra 的标准管理队列

结局

ICANS 发生率、3 级 ICANS、住院时间、CAR-T 扩增、OS/PFS 和耐受性

结论

这项 Bern 单中心真实世界回顾性研究分析 80 例接受 CD19 CAR-T 的 B 细胞淋巴瘤患者，比较 day 0 至 +6 预防性 anakinra 与未使用 anakinra。ICANS 发生率为 35% vs 25%，差异无统计学意义；3 级 ICANS 20% vs 18%，也相近。anakinra 未影响 CAR-T 扩增，耐受性良好；在发生 ICANS 的患者中住院时间数值上更短。结论是预防性 anakinra 未降低 ICANS 发生率或严重程度，但仍可能影响毒性管理路径。

主要内容

- 人群：2019-04 至 2022-06 在 Bern University Hospital 接受 tisa-cel、axi-cel 或 liso-cel 的 80 例 B 细胞淋巴瘤患者。
- 干预：anakinra 100 mg 皮下注射 day 0 至 +6；对照为标准管理队列。
- 主要安全性：ICANS 14 例（35%）vs 10 例（25%）， $p=0.464$ ；3 级 ICANS 8 例（20%）vs 7 例（18%）， $p>0.999$ 。
- 其他观察：anakinra 未削弱 CAR-T 扩增，未见治疗相关 AE；OS/PFS 相似；发生 ICANS 者住院时间 27 vs 40 天， $p=0.077$ 。

关键信息

- 作者：Tina Schmid、Inna Shaforostova、Ulrike Bacher、Katja Seipel、Marie-Noelle Kronig、Thomas Pabst 等。
- 核心问题：IL-1 阻断是否能预防 CAR-T 相关 ICANS。
- 核心结论：真实世界回顾性队列未显示 ICANS 发生率或严重程度下降；但住院时间有数值下降趋势。
- 方向标签：CAR-T、ICANS、anakinra、IL-1、neurotoxicity、real-world safety。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确报告预防性 anakinra 与标准队列的 ICANS、3 级 ICANS、CAR-T 扩增、OS/PFS 和住院时间数据。

论文作者观点

论文作者观点：预防性 anakinra 未能降低 ICANS 发生率或严重程度，但可能与 ICANS 患者住院时间缩短相关；是否为直接治疗效应仍不确定，需要更大前瞻研究。

我的推断

我的推断：CAR-T 支持治疗研究应把“预防发生率”和“降低管理负担/住院时间”分开设终点；当前数据不支持把 anakinra 预防写成已验证标准策略。

PCNSL 机制治疗更新：KPT-8602 + IFN- γ 激活 ZBP1-PANoptosome 抑制肿瘤进展

KPT-8602 combined with IFN- γ released ZBP1-PANoptosome to inhibit the progression of primary central nervous system lymphoma.

PMID 41720446

打开 PubMed

CNSL / PCNSL / 靶向联合与 PANoptosis 机制

primary central nervous system lymphoma

MDAT 命中: MDAT 记录更新; 原始发表日期为 2026-04-15, 不是本周新发表

人群

PCNSL 相关淋巴瘤细胞系和脑内移植小鼠模型

干预/暴露

KPT-8602 + IFN- γ 联合处理

比较

单药组和未联合处理组

结局

细胞生长、apoptosis/PANoptosis、ZBP1/PANoptosis 蛋白、肿瘤体积、TUNEL 阳性和 CSF 炎症因子

结论

这项实验研究评估 KPT-8602 与 IFN- γ 是否通过 ZBP1 介导的 PANoptosis 抑制 PCNSL。体外使用 Raji 和 U-2932 细胞，体内建立立体定位脑内移植 PCNSL 小鼠模型。联合治疗对淋巴瘤细胞生长有协同抑制作用 (CI<1)，增强凋亡和 PANoptosis，升高 IL-18、IL-1 β 及相关蛋白；小鼠模型中联合组肿瘤体积小于单药组，并见 TUNEL 阳性和 CSF 炎症因子变化。该文是 PCNSL 靶向联合机制假设，不是临床疗效证据。

主要内容

- 研究目的：测试 KPT-8602 与 IFN- γ 是否能通过 ZBP1-mediated PANoptosis 抑制 PCNSL 进展。
- 模型：Raji、U-2932 淋巴瘤细胞；CCK8、流式、YO-PRO/PI、Western blot；并建立小鼠脑内 PCNSL 移植模型。
- 体外结果：联合治疗对细胞生长呈协同抑制，增强 apoptosis/PANoptosis，上调 IL-18、IL-1 β 和 PANoptosis 相关蛋白。
- 体内结果：联合治疗组肿瘤体积小于单药组，TUNEL 阳性增加，CSF 中 IL-6 和 CXCL13 升高，肿瘤组织 Western blot 支持 PANoptosis 通路激活。

关键信息

- 作者：Wei Jiang、Nannan Ren、Tingting Wang、Xiaoxiao Man。
- 性质标注：MDAT 更新的 PCNSL 机制/前临床研究，非本周新发表临床研究。
- 核心机制：KPT-8602 + IFN- γ -> ZBP1 上调 -> PANoptosome/PANoptosis 激活 -> PCNSL 生长抑制。
- 方向标签：PCNSL、KPT-8602、IFN- γ 、ZBP1-PANoptosome、PANoptosis、CNS 药物机制。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确报告 KPT-8602 + IFN- γ 在体外和 PCNSL 小鼠模型中激活 PANoptosis 并抑制肿瘤生长，且联合组优于单药组。

论文作者观点

论文作者观点：KPT-8602 与 IFN- γ 联合可通过上调 ZBP1 激活 PANoptosis，可能成为 PCNSL 的新联合治疗策略。

我的推断

我的推断：PCNSL 新药研究可关注“CNS 可达性 + 细胞死亡通路激活 + CSF 炎症/肿瘤标志物”组合终点；但目前仍是前临床机制研究，不能写成已验证的临床治疗方案。

今日综合判断 · 2026-06-13

今日重点不是单个药名，而是 CNS 预防、双抗固定疗程、CAR-T 前处理药代和免疫微环境分层这些可改变研究设计的变量。

已验证证据

本轮官方候选池 293 条，精选 5 篇未跨日重复 PMID: 42284198、42283231、42278654、42279369、41720446。已验证证据覆盖 PD-1/TIGIT 双敲低 CD19 CAR-T 的 R/R LBCL I/II 期信号、Mosun-Pola 随机 II 期双抗+ADC 数据、epcoritamab 小队列真实世界疗效与 TCR/CTL 重塑、预防性 anakinra 未降低 CAR-T ICANS 发生率，以及 KPT-8602 + IFN- γ 在 PCNSL 前临床模型中激活 PANoptosis 的机制证据。

论文作者观点

论文作者共同指向的方向是：R/R LBCL 免疫治疗正在从单纯药物类别比较，推进到产品工程化、固定疗程双抗+ADC、免疫 repertoire 监测、毒性管理和机制分层；PCNSL 方向则继续需要把 CNS 可达性、细胞死亡通路和 CSF/肿瘤微环境指标纳入新方案假设。

我的推断

我的推断是，今天最值得跟踪的研究变量有五个：CAR-T 产品是否通过内建检查点调控延长反应、双抗+ADC 固定疗程能否成为可及的即用方案、epcoritamab 反应/停药是否有可测免疫标志物、CAR-T 支持治疗终点是否应从 ICANS 发生率扩展到住院和管理负担、PCNSL 前临床方案是否能同时证明 CNS 可达性和通路激活。以上仅用于文献监测和研究设计启示，不构成治疗推荐。

固定本地文件：pubmed-pages/index.html。固定公网链接：<https://zhengyi-pharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>。PubMed 链接均使用 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/\[PMID\]/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/[PMID]/) 格式。